

4단원 癥瘕 & 부인 중양학 및 유방 질환

제 1장 癥瘕

癥瘕에 대한 교과서 내용

① 癥瘕(징가)

- 여성의 생식기관에 발생하는 종괴를 통칭
- 癥(징) : 형태가 있으면서 단단하여 이동하지 않고 밀더라도 움직이지 않음
- 瘕(가) : 형태가 없으면서 흩어졌다 뭉쳤다 할 수 있고 밀면 움직이는 것

② 積聚(적취)

- 積(적) : 쌓인것으로 癥과 유사
- 聚(취) : 뭉쳤다가 흩어지는 것, 瘕와 유사

③ 癥瘕(징가), 積聚(적취), 瘕癖(현벽)의 구분

- 癥瘕 : 下焦의 병 / 여성 고유의 종괴
- 積聚 : 中焦의 병 / 肚腹內(두복내)에 발생
- 瘕癖 : 上焦의 병 / 胸膈間(흉복간)에 발생 / 남녀 모두에게 발생 가능

④ 腸覃(장담), 石瘕(석가), 血蠱(혈고)

- 腸覃 : 腸外, 즉 자궁과 장 사이에 발생 / 난소에 생긴 기능성 낭종과 대응
- 石瘕 : 胞中에서 발생 / 자궁에 생긴 종
- 血蠱 : 특정한 종괴라기보단, 각종 부인과 중양의 심한 상태를 묘사

※기본 치법※

- 活血化癥, 軟堅散結을 위주로 하고 정기 부족 시 養正
- 이때 攻이 지나치면 위중할 수 있으니 어느정도 치료되면 중단하여야한다.

1. 병인병기

- 징가의 병인은 다양하나 병리변화의 주요인은 *기체혈어
- 습담, 습열, 식적 모두 기체혈어를 이루는 병리인자
- 병변부위
: 자궁, 포맥, 충임맥
- 초기에는 실증이 많고 만성화되면 허실협잡인 경우가 많다.

징가의 병인

기체	- 병리변화의 주된 요인으로, 주로 七情內傷에 기인
어혈	- 월경기나 산후에 정기가 허약해져 혈실이 열린 상태에서 風寒을 감수 하거나, 성생활이 문란하여 餘血과 敗精이 들어와 瘀 형성 - 瘀結成癥한 이후에는 아래 두 방향으로 진행 ① 양기손상 → 인체기능 쇠퇴 → 수습운화 X → 부종과 복수가 생김 ② 음혈모손 → 기육경맥 자양 X → 부정출혈
습담	- 肝脾腎의 기능실조와 관련 - 기혈, 진액이 蘊蓄되거나 습담이 內蘊한 것이 오래되어 생김
이외	식적 -> 산사를 군약으로 사용함

2. 변증치료

기체	종괴가 견고, 이동성O, 부위, 통증유무, 위치 일정X 월경량 감소, 월경통, 소복창통, 긴장, 정신 억압	
	행기도체 파어소징	대칠기탕
혈어	종괴가 단단, 고정, 통증 심함, 월경량 많음, 월경 자흑색, 덩어리O, 피부 윤택X,	
	활혈화어 파적소징	계지복령환
습담	종괴가 유연, 동통, 대하 양 많음, 홍복부 더부룩	
	이기화담 파어소증	개울이진탕

+) 붕루의 원인이 어혈일 경우에 지혈하는 법

: 화어지혈약을 사용함(Ex. **가미실소산**)

보통 癥疾의 유일한 처방인 계지복령환이 듣지 않을 때 사용함

- 대하의 양이 많지 않을 경우 의이인·백지 가미
- 경행복통이 심한 경우 현호색·유향·몰약
- 월경량 적거나 무월경인 경우 우슬·택란

제 2장 자궁 및 자궁목의 종양

1절 자궁근종

1. 개술

- 가장 흔한 여성 골반 내 종양
- 난소 기능이 활발할 때 잘 발생하며, 폐경기 이후에 발생하는 일은 없고 오히려 있던 근종도 위축되는 것으로 보아 에스트로겐 의존성 종양으로 생각된다.
- 자궁 평활근 내에 있는 하나의 신생세포에서 기인한다고 추측됨

※위험인자

위험도 증가	1. 초경이 빠를수록 2. 육류섭취군 3. 여성호르몬 투여시 4. 과체중
위험도 감소	1. 출산력이 있는 경우 2. 흡연

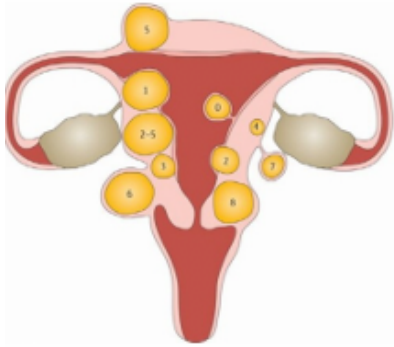
3. 발생부위 및 발생 형태

- 부위 : 평활근이 많이 있는 자궁 체부(= 자궁몸통)에서 빈발
- 분류: 발생위치에 따라 근층내 근종, 점막하 근종, 장막하 근종

근층내근종	근층 내 존재, 전체의 80%
점막하 근종	자궁내막 바로 아래에서 생겨 자궁내강으로 용종처럼 돌출(합병증 많음)
장막하근종	장막아래 존재

+ 자궁경부나 자궁인대 등에서도 가끔 발생함

(참고) 발생위치에 따른 FIGO분류



0. 자궁내강에 있음

1. 자궁근종 직경의 50% 이하가 자궁근층 내에 존재
2. 자궁근종 직경의 50% 이상이 자궁근층 내에 존재
3. 자궁내막에 닿아 있으나 100% 벽 내에 존재
4. 자궁내막이나 장막에 닿지 않고 자궁근층 내에 존재
5. 최소 50% 이상이 벽내에 존재하는 장막하근종
6. 50%미만이 벽내에 존재하는 장막하 근종
7. 장막하 근종이 유경성으로 장막에 달려 있음
8. 자궁근층에 존재하지 않는 것

4. 자궁근종의 2차적인 변화

- 자궁근종의 육안적 소견은 경계가 명확하고 둥글고 단단한 회백색의 종괴
- 절개해보면 평활근들이 소용돌이 모양을 이루며 배열되어 있어 쉽게 구별되고 주위 조직으로부터 잘 박리됨
- 하지만, 근종의 증대와 이에 따른 혈관발달이 원활하지 못하여 순환장애로 인해 변성됨

초자성 변성	초음파로는 구별이 어려움, 가장 흔함 콜라겐 섬유가 굳어짐(초자)
낭포성 변성	초자성 변성 후 액화되어 발생
석회화 변성	칼슘이 쌓인 것
감염과 화농	점막하 근종에서 흔함
괴사	적색변성에서 잘 나타남 적색변성 : 발열, 압통, 백혈구증가증을 동반한 심한 복통의 급성 외과적 복증
지방성 변성	
육종성 변성	암으로 악성화 된 것. 아주 드물 (0.1-0.6%)

5. 임상증상 및 징후

- 자궁근종 환자 모두에서 증상이 나타나는 것은 아니고 대략 20~50%

1) 종괴감

- 하복부에 종괴 만져지거나 팽만(장막하 근종에서 다발)

2) 비정상 자궁출혈

- 가장 흔한증상(33%), 임상적 중요성이 높다
- 점막하근종에서 심하다

3) 골반통

- 2번째로 흔히 나타나는 증상으로 동통과 압박감
- 임신기간 중 자궁크기 증가로 가지게 되는 불편감과 유사
- 비뇨생식기계 및 소화기계, PID, 자궁내막증 가능성 고려

4) 압박증상

자궁후벽의 근종	요통
광인대 근종	일측성 하복부 동통, 좌골신경통
전벽 근종	방광압박, 불편감
거대 근종	요로증상(방광압박) 변비(직장압박)
자궁경부 근종	배뇨장애(요저류)

5) 2차적 증상

- 만성 출혈에 의한 빈혈
- 전신쇠약, 권태감, 두통, 심계항진이 나타남

6. 자궁근종과 임신

- 자궁근종의 난임에 대한 영향

① 정자나 배아의 이동방해

② 임신유지에 필요한 용적 감소

③ 혈류의 변화

④ 자궁내막 조직의 변화

- 메타분석 결과

- 점막하 근종 : 60~70% 임신율 감소, 유산 2~3배 증가
점막하 근종을 근종절제술 하면 약 2배 임신율 상승
- 근층내 근종 : 20~30% 임신율 감소, 유산율 약간증가
근층내 근종을 근종절제술 하면 임신, 유산율에 영향X

1) 임신시기에 따른 근종의 변화 & 합병하는 산과적 문제

- 임신기간 동안 일어나는 E/P 합성의 현저한 증가가 자궁근종 크기증대와 관련
- 다만, 자궁근종의 20~30%만 임신기간 중 크기 증가, 늘어나더라도 최대 25%

① 제 1삼분기(14주) : 자궁출혈 및 자연유산의 빈도 증가

- 근종크기 변화 X, 경미한 증가

② 제 2삼분기(15~28주) : 적색변성

- 2~6cm 근종 : 변화 X / 6cm 이상 : 감소

③ 제 3삼분기(29~42주) : 분만: 태아 위치 이상과 난산

- 근종의 변화 X, 감소

④ 산후: 출혈이나 자궁내막의 염증 유발

⑤ 신생아: 낮은 Apgar 점수, 저체중아 위험성 증가

7. 진단

복부촉진	일부 경우 복벽 통해 단단하고 불규칙한 덩어리 촉진
양수골반검진	방광이 빈 상태에서 근종크기와 자궁내의 위치를 예측하는 방법
X-선	커다란 근종은 하복부/골반의 사진에서 연조직 종괴로 나타남
초음파검사 (복부초음파)	- 횡단스캔 : 자궁 및 양측 부속기를 관찰 - 종단스캔 : 질, 자궁경관, 자궁체부, 자궁저부 경계 관찰
특수검사	자궁촬영술, 자궁경검사법 - 점막하근종 확인 진단복강경검사 - 종양의 기원 확정 MRI - 자궁근종, 자궁선근증 감별

8. 의과치료

1) 기대요법 및 정기적 검진

- 무증상이면서 임신 12주째의 자궁 크기(8cm) 이하로 자라지 않으면 규칙적 검사 반복하면서 지켜보는게 원칙
- 6개월 간격의 정기적인 검진이 일반적

2) 호르몬 요법

- 일차적으로 출혈을 예방하기 위한 일시적 치료법
- 주로 Gn-RH agonist를 3개월 정도 투여
 - : 가성 폐경 상태를 만들기 위함으로, 6개월 이상 X (골다공증 우려)

3) 수술요법

- 대원칙은 증상이 없는 자궁근종은 수술하지 않음

① 자궁근종절제술

- 자궁을 보존하고자 하거나 임신을 원하거나, 자궁이 지나치게 증대되지 않았거나, 근종이 많지 않은 경우 시행
- 대부분 복강경 수술을 이용하며, 20-25% 재발 가능성
- 자궁절제술보다 수술 난이도 / 위험도 높음

② 자궁절제술 - 부인과 수술중 가장 높은 빈도 차지

- **적응증 다섯 가지

- : 호르몬 치료에 반응 없는 빈혈 동반한 부정 질 출혈
- : 월경통, 성교통, 아랫배 압통을 동반한 만성 골반통
- : 유경선 근종이나 점막하근종의 탈출로 인한 급성통증
- : 신부전증을 동반하는 비뇨기계 증상
- : 갑작스러운 자궁크기 증가로 인한 압통 및 통증증가

BUT, 폐경기 이후 근종의 크기 증가

- > 육종변성, 난소 종양의 가능성 존재
- > 시험적 개복술이 필요함

③ 근종용해술

- 근종의 혈류 응고시켜 크기 줄임
- 시술이 간단하고 손상을 최소화할 수 있지만 완치가 아니라 증상의 완화를 위함

④ HIFU

- 인체에 무해한 고강도 초음파를 체외에서 인체 깊숙한 곳에 위치한 종양에 집중시켜 괴사시키는 치료법
- 초음파영상 유도방식과, 자기공명영상 유도방식 있음

9. 변증치료

1) 비월경기 치료 -> 파어소징 위주의 치료

기체혈어	정신긴장, 유방창통, 흉협고만, 가슴답답	
	소간이기 활혈화어 연견산결(軟堅散結)	격하죽어탕, 화어소징탕
한습응체	복부에 징하적취, 대하 지속적으로 나옴, 형한지냉	
	온양산한 활혈화어 연견산결	계지복령환, 조습화담연견탕(燥濕化痰軟堅湯)

2) 월경기 치료 -> 부정출혈에 중점, 출혈방지에 초점(붕루치법과 유사)

기허혈어	월경량 과다, 붕루 양상, 소량 출혈, 현훈, 피로, 경계, 천급	
	익기양(養)음거어지혈	고본지붕탕(固本止崩湯), 거원전(舉元煎)
어열교조 瘀熱交阻	월경량 많음, 소량 출혈, 소복통, 현훈, 눈 붉음, 건조, 불면, 답답	
	청열화어량(涼)혈지혈	죽어지혈탕
음허내열	월경량 많지 않음, 현훈, 경계, 허리가 시큰함, 건조	
	양(養)음청열량(涼)혈지혈	청해환(淸海丸), 고경환(固經丸)

+) 지혈약으로 지유, 형개, 초오도 많이 쓰지만

상중하초 어느 출혈에 쓸 수 있는 지혈약이 '선학초(=용약초)(=짚신나물)'

10. 처방치료

- 계지복령환, 굴려산결환 등을 사용함

2절. 자궁경부암

1. 개술

1) 자궁경부의 상피구조

- ① 외자궁경부 : 편평상피세포로 구성 / 질 부위와 접해 있음
- ② 내자궁경부 : 원주상피세포로 구성 / 점액을 분비하며 자궁내강 출입구
- ③ 편평·원주 접합부 (= 변형대)
 - : 생리적 변화에 의해 원주상피세포 → 편평상피세포
 - 변화과정 중 암 발생 자극에 노출이 되면 이형세포로 변화됨

※ 자궁경부이형성증(CIN)과 자궁경부상피내암

- 이형 세포가 생기는 것과 자궁경부상피내암을 구분하기 위해 이형증 개념 도입
- 자궁경부이형성증 = 자궁경부상피내종양 (CIN)
 - 이형정도를 3단계로 나눠 분류 (CIN1 : ~ 1/3 , CIN2 : ~ 2/3 , CIN3 : 2/3 이상)
- 자궁경부상피내암
 - 상피의 최상표층까지 이형세포로 치환된 경우

2) 역학

과거 여성암의 1위 ➡ 발생률 점차 감소 ➡ 현재 10위
대신 자궁경부상피내종양(CIN)과 자궁체부암의 발생률이 증가

3) 호발연령

- 자궁경부상피내종양 : 20~30대
- 자궁경부 상피내암 : 35~40대
- 침윤성 자궁경부암 : 40~50대

2. 원인

- 여러가지 외부요인에 의해서 영향을 받음
- 주원인은 HPV감염으로 인해 이루어짐(99.7%이상)

1) HPV 유형

- 상피내암 환자에서 20 종의 HPV 고위험군이 발견
- 주로 발견되는 13 종 고위험군은 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68(13 종)
- HPV 16, 18, 58, 35 번이 상위 4 개(한국), 16 번이 가장 흔함

16	편평세포암종과 관련
18	예후가 좋지 않은 자궁경부선암(10~15%)
16&18	전체 자궁경부암의 70%
58	극동지역 자궁경부암(10%)

- HPV와 자궁경부암
- HPV 감염 여성의 10~20%만이 지속성 감염으로 이어져 자궁경부암 전단계로 진행
- HPV 감염 이후 자궁경부암 발생까지 약 10~20년 소요, 바이러스 감염 여성 1% 미만에서 침윤성 자궁경부암 발생

3. 일반증상

- 대부분 증상이 없음
- 성교 후 경미한 질출혈이 가장 흔한 증상
 - : 초기에는 정상출혈로 시작되어 진행되면서 출혈과 분비물 증가+ 악취
- 암 조직이 주변 장기를 침범
 - : 배뇨곤란, 혈뇨, 직장출혈, 요천통, 하지의 동통 및 부종, 체중감소

4. 임상병기 분류

제 0 기 상피내암			
I 기	암이 자궁경부에만 국한		
	I A 기	기질 침윤깊이 5mm 미만, 현미경으로만 진단	
		I A1 기	기질 미세침윤 깊이 3mm 미만
		I A2 기	기질 미세침윤 깊이 3-5mm
	I B 기	기질 미세침윤 깊이 5mm 이상	
		I b1 기	종양 크기 2-4cm
		I b2 기	종양 크기 4cm 이상
II기	암이 자궁경부 벗어났으나, 골반벽에는 도달 Xor 질을 침범했으나 하부 1/3 까지는 도달 X		
	IIA 기	질 상부 2/3 침범	
		IIA1 기	종양 크기 4cm 미만
		IIA2 기	종양 크기 4cm 이상
	IIB 기		자궁 주위 조직 침범
III기	암 침윤이 골반벽에 도달 or 질 하방 1/3 까지 침범, 수신증 or 기능 상실 신장이 확인될 때		
	IIIA 기		질하방 1/3 까지 침범했으나

			골반벽까지는 도달 X
	IIIB 기		골반벽에 도달 or 경정맥 신우조영술상 수신증이나 신장 기능상실
	IIIC 기	골반벽 침범 또는 대동맥 주위 림프절 전이	
		IIIC1 기	골반 림프절에만 전이
		IIIC2 기	대동맥 주위 림프절 전이
	IV기	암이 골반 밖으로 진행 or 방광 또는 직장 점막 침범	
		IVA 기	인접 장기 침범
		IVB 기	원격 장기에 전이 되었을 때

+) 임상병기별 치료

제 0 기	- 전기소작, 냉동요법, 원추생검, 자궁경부 절단술 등 보존적 치료 - 임신 원하지 않는 경우 자궁적출술 시행
제 1a 기	- 침윤이 기저막에서 3mm 이하, 혈관·림프관 침범 X, 융합성 침윤이 아니면 자궁절제술만. - 이 기준 이외의 경우 제 1b 기에서와 동일
제 1b 기	- 자궁경부 및 자궁 경부 주위 조직, 골반 림프절을 함께 치료
제 2a 기	- 근치적 자궁절제술 및 양측 골반 림프절 절제술 or 방사선 치료 시행
제 2b ~ 4a 기	- 수술로 해결이 되지 않는 단계 (거의 수술 X) 방사선 치료

7. 예후

- 환자의 임상 병기와 직접적으로 관련
 - : 방사선 치료 시에는 소세포암의 예후가 대세포 비각질화형보다 나쁜단 보고
- 같은 임상 병기에서도 종괴의 크기, 조직학적 분화도, 림프관·혈관의 침범, 림프절의 전이, 침윤깊이, 자궁체부로의 침윤 등에 따라 예후에 차이를 보임
- 체부암 등 다른 암보다 생존률이 낮다

8. 특별한 고려 상황

① 자궁경부 절주암

- 방사선 치료 시 짧은 경부로 인해 조사량 제한되므로 외부 조사를 고용량으로 시행

② 단순적 자궁절제술 후 발견된 침윤성 자궁경부암

- 자궁적출술이 암을 완전히 제거하지 못했다고 생각되므로 수술 후 방사선 치료

③ 자궁경부선암

- 치료는 편평세포암과 동일, 근치적 자궁적출술 또는 방사선 치료 시행

④ 솔통형 자궁경부내암

⑤ 재발된 자궁경부암

- 정의 : 치료 완료 이후 6개월이 지난 이후에 암의 존재가 다시 발견된 경우
- 예후 : 1년생존율 15% / 5년생존율 1% 미만 (예후 좋지 않음)

⑥ 임신과 동반된 자궁경부암

- 임신 제 24주 이전 → 비임신 상태와 동일하게 각 임상병기에 따르는 치료시행 : 근치적 자궁적출술, 골반 림프절 절제술 OR 방사선 치료
- 임신 제 28~32주에 발견 : 제왕절개 분만 후 각 임상 병기에 따르는 치료

9. 한방치료

- 봉루, 대하, 징가의 범주에서 증상과 치료법을 찾아볼 수 있음
- 자궁경부암은 습열온독이 자궁을 침범하여 생긴 병증
- 肝鬱,脾胃虛弱,陰虛,陽虛을 겸함

변증치료

습열어독	축양천산가미
정허어독	보중익기탕가감, 팔진탕가감

+) 일본의 한 연구를 살펴보면 한약병용 치료군의 생존율이 유의하게 높음
처방은 십전대보탕, 팔미지황환, 인삼영양탕, 보중익기탕, 사령탕을 사용함

3절 자궁내막암

교과서 간단 정리

여성들의 식생활 변화, 호르몬 요법의 증가, 임신, 초경 및 폐경 연령의 변화 및 평균 수명의 연장으로 자궁내막암이 호발되는 폐경기 후의 연령층 증가

→ 우리나라 여성생식기 암 중 자궁경부암 난소암 다음으로 높음

→ 2020년 기준으로 3위에서 더 상승

1. 원인

원인분류

1) 에스트로겐 의존성 종양

- 젊은 여성, 폐경기 전후 여성
: P에 의한 길항작용이 없는 내인성/외인성 E에 노출
- 자궁내막증식증에서 시작하여 악성종양으로 발전
- 예후 양호

2) 에스트로겐 비의존성 종양

- 고령 여성, 폐경기 이후 여성, 저체중 마른 여성
- 자궁내막증식증과 관련 X, 위축성 자궁내막에서 발생
- 예후 불량

위험요인

- ① 미산부 (경상부에 비해 2~3배의 발생빈도)
- ② 무배란성 월경에 의한 불임증
- ③ 월경불순
- ④ 폐경 나이 늦은 여성
- ⑤ 비만(3~10배), 당뇨(2.8배), 고혈압(1.5배)
- ⑥ 폐경 후 에스트로겐 보충요법 (장기간 E에 노출될 수 있는 조건들)

2. 일반증상

- 5% 미만에서 무증상, 90%에서 부정 질출혈과 대하
- : 폐경기나 폐경 전 과다월경 또는 부정 질 출혈 발생
- : 혹은 폐경연령에 주기적인 출혈이 계속 있는 경우 자궁내막암을 의심

폐경 후 출혈 원인

- ① 자궁내막위축증 (60~80%)
- ② 호르몬 대체요법 (10~15%)
- ③ 자궁내막암 (약 10%)
- ④ 자궁내막용종, 자궁내막증식증
- ⑤ 기타 : 자궁비대, 자궁 밖으로 전이 있으면 골반통, 말기가 되면 다른 암처럼 체중감소, 전신쇠약, 심한 출혈로 빈혈 등

3. 진단

- 자궁내막의 조직검사에 의해 이루어짐
- 부정자궁출혈이나 자궁내막병변이 의심될 때 첫단계 : 자궁내막 흡인 생검
- 자궁경 조준생검은 가장 확실한 진단 방법
- 실제로는 임상적 병기결정보다는 수술적 병기 기준이 채택되어 활용

‘자궁내막암의 FIGO 수술적 병기 결정’

병기	분화도	기술
I A	1-3	자궁내막에 한정
I B	1-3	자궁근층 1/2 미만 침범
I C	1-3	자궁근층 1/2 이상 침범
II A	1-3	자궁경부 샘 조직 침범
II B	1-3	자궁경부 기질 침범
III A	1-3	자궁작막, 자궁부속기 침범 또는 양성 복강세포검사
III B	1-3	질에 전이
III C	1-3	골반주변 또는 대동맥주변 림프절에 전이
IV A	1-3	방광 또는 장 점막에 침범
IV B	1-3	복강내 전이 또는 서혜부림프절 전이를 포함하는 원격 전이

4. 치료

- 치료의 기본 : 자궁절제술 및 양측 부속기 절제술
- 저위험군 / 중간위험군 / 고위험군으로 나누어 경과관찰, 방사선치료, 보조적 황체 호르몬 투여, 항암화학요법 등 시행

+) 참고

저위험군	재발가능성 낮음, 추가치료 불필요
중간위험군	추가치료해도 큰 도움이 되지 않음
고위험군	재발가능성 높음, 추가치료 필수적

5. 한방치료

- 주된 증상인 출혈과 대하 : 붕루, 대하, 징가의 범주
- 수술적 처치 후의 후속 한방치료와 수술적 처치 시기를 놓친 경우로 구분하여 치료

① 수술 후 환자 : 정기허약에 대한 扶正 및 부작용 감소 ex) 향사육군자탕

② 수술적 치료 시기 놓친 경우 : 간신음허, 습독온결

- 자음강화해독 : 지백지황탕 가 白花蛇舌草, 半枝蓮, 半邊蓮
- 화습청열해독 : 清化煎 가감, 愈黃丹 가감

4절 자궁육종

이 파트는 숙하고 넘어가셔서 중요하게 보지 않으셔도 될 것 같습니다

1. 위험인자

- 체중이 증가할수록, 나이가 많을수록, 미산부
- 다른 질환으로 골반 방사선 치료 받은 후 자궁육종 빈도 증가

2. 일반증상

- 비정상 자궁질출혈이 가장 흔한 증상, 무증상인 경우도 있음
- +) 복통, 커진 골반종괴로 인한 압박감

3. 진단

- 병기는 국제 산부인과연맹 분류법에 근거하여 나눔
- 병기 1,2기에서 5년 생존율이 52%, 66%
➔ 3,4기에서 각각 37%와 0%로 나타남

4. 한방치료

- 자궁내막암에 준하여 치료
- 기체혈어 : 대황자충환
- 습열어독 : 대황목단피탕 합 사묘환